

今日课程
即将开始
请您静候





考 前 串 讲 课

变态心理学考点串讲

授课教师：田琪

第四章 变态心理学与健康心理学

一、变态心理学概述

五、心理健康与心理不健康

二、心理正常与心理异常

六、心理不健康状态的分类

三、常见心理异常的症状

七、关于健康心理学

四、常见精神障碍

八、压力与健康

章节	考点数	历年真题占比	常考题型	掌握程度
概述	1	5%	单选题	★
心理正常与心理异常	2	6%	单选题	★★
常见心理异常的症状	8	35%	单选题	★★★★★
常见精神障碍	6	25%	单选题	★★★★★
心理健康与心理不健康	4	17%	单选题	★★★★
心理不健康状态的分类	0	0	无	★
关于健康心理学	1	5%	单选题	★
压力与健康	1	7%	多选题	★

第一节 概述

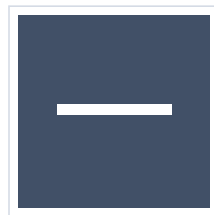
C O N T E N T S



变态心理学的对象



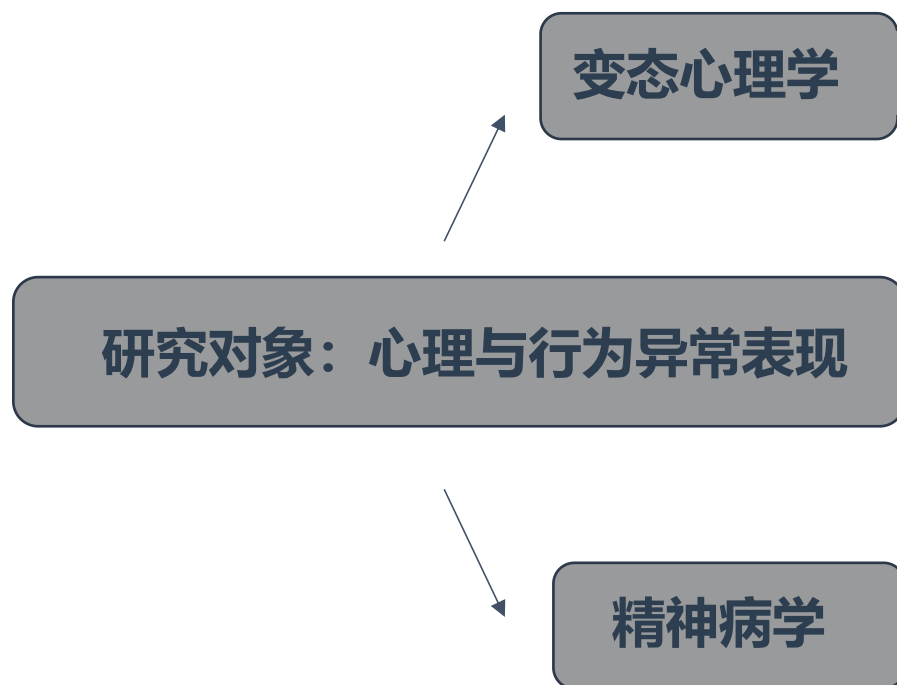
学科简史



变态心理学的对象

变态心理学的对象

考点P4



心理学的分支;
心理异常的基本性质与特点; 个体心理差异;
生存环境对心理异常发生、发展的影响。

临床医学分支;
异常心理的**诊断、治疗**、转归、预防与**康复**。



学科简史

一、对心理异常现象的早期关注

公元前400年，希波克里特提出体液学说，认为心理异常是有害体液流入大脑造成的

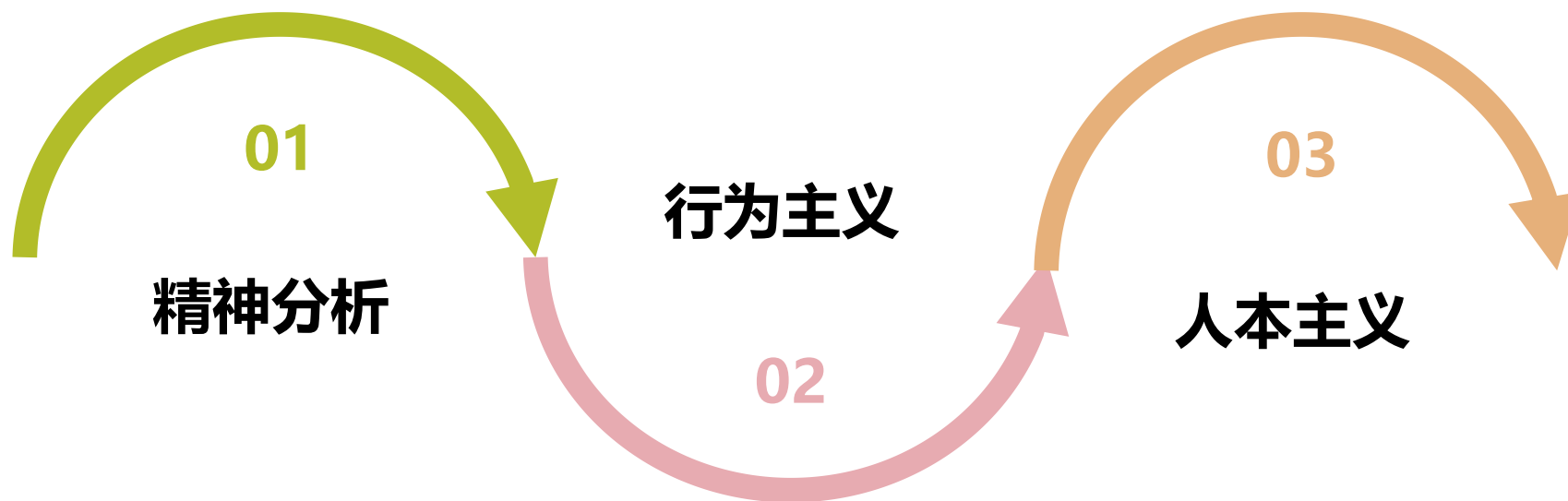
5-16世纪，宗教神学镇压体液学说，心理异常被看作魔鬼附身

17世纪，**自然科学的出现，使人们再一次把心理的异常现象和大脑的功能联系在一起**



二、对心理异常现象的现代说明

始于20世纪



(一) 精神分析的理论解释

1. 两个基本命题



基本命题

心理过程主要是**潜意识**的

性的冲动，狭义和广义的，都是神经症和精神病的重要起因

基本命题



(一) 精神分析的理论解释

2.五个推断

- (1) 心理结构：潜意识、前意识和意识；
- (2) 人类的生物本能是心理活动的动力 “力必多”

libido
n. 性欲；生命力

早期：性本能和营养本能

后期：生本能（包括性本能和营养本能）和死本能

(一) 精神分析的理论解释

2.五个推断

(3) “力必多”在幼年期驱动人的**性心理发展**，有不同阶段：

口欲期
(0-1岁
左右)

肛欲期
(1-3岁)

生殖器期
(3-5岁)

潜伏期
(5-12岁)

生殖期
(12岁以后)

(一) 精神分析的理论解释

2.五个推断

(4) 人格结构:

本我 — **快乐原则**;

自我 — 现实原则;

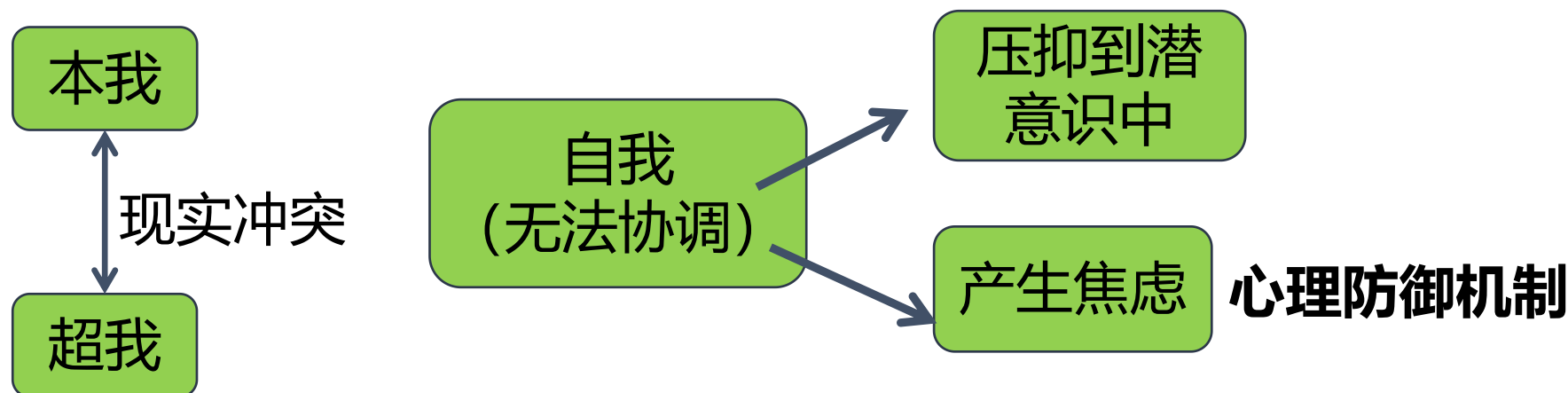
超我 — 道德原则。



(一) 精神分析的理论解释

2.五个推断

(5) 人具有防止焦虑的能力—“防御机制”



“防御机制”是**自我**的功能

(一) 精神分析的理论解释

3.对心理异常现象的说明

- (1) **“固着”**。合理地度过“性心理”发展的每个阶段，是未来心理健康的充分和必要条件，发展受挫会造成“固着”。
- (2) **焦虑**。由于我们的“自我”必须随时随地的学习外部世界，以便理性地处理“本我”与“超我”之间的冲突和矛盾，所以我们体验着焦虑。
- (3) **压抑**。克制、压抑非理性冲动，导致两种后果：压抑力量不足，就会体验到痛苦；压制得住会导致潜意识中冲突的变形。

(二) 行为主义的解释

考点P7

巴甫洛夫用**高级神经活动学说**直接说明人的异常心理现象，是行为主义心理学介入变态心理学的早期记载。

神经衰弱：特征是**兴奋过程**的优势和**抑制过程**的薄弱；

癔病：特征是**抑制过程**的优势和**兴奋过程**的薄弱。



考点P7

(三) 人本主义的理论解释

“潜能”——具有趋向完善的特点



受阻



“自我”无法实现

心理
异常

最基本的表现：

“存在焦虑”



“存在”和“责任”
的冲突

总结

第一节 变态心理学概述

研究对象：心理与行为的异常

临近学科

精神病学是变态心理学的临近学科

相同--研究对象

不同--研究目的

变态心理学：心理学分支；
心理异常的基本性质和
特点

精神病学：临床医学分支；
研究心理异常的诊断、
治疗等

发展史

体液学说

宗教认为心理异常是魔鬼附身

自然科学的出现，使心理异常和大脑功能联系起来

扫二维码
获取更多心理资讯

总结



第一节 对心理异常的解释

精分—弗洛伊德

意识分域--意识、前意识、潜意识

人格结构--本我、自我、超我

人格发展--口、肛、性器、潜、性

人格动力--力比多、焦虑、压抑

行为—巴甫洛夫：兴奋和抑制过程

人本—马斯洛：存在焦虑

第二节 心理正常 与异常

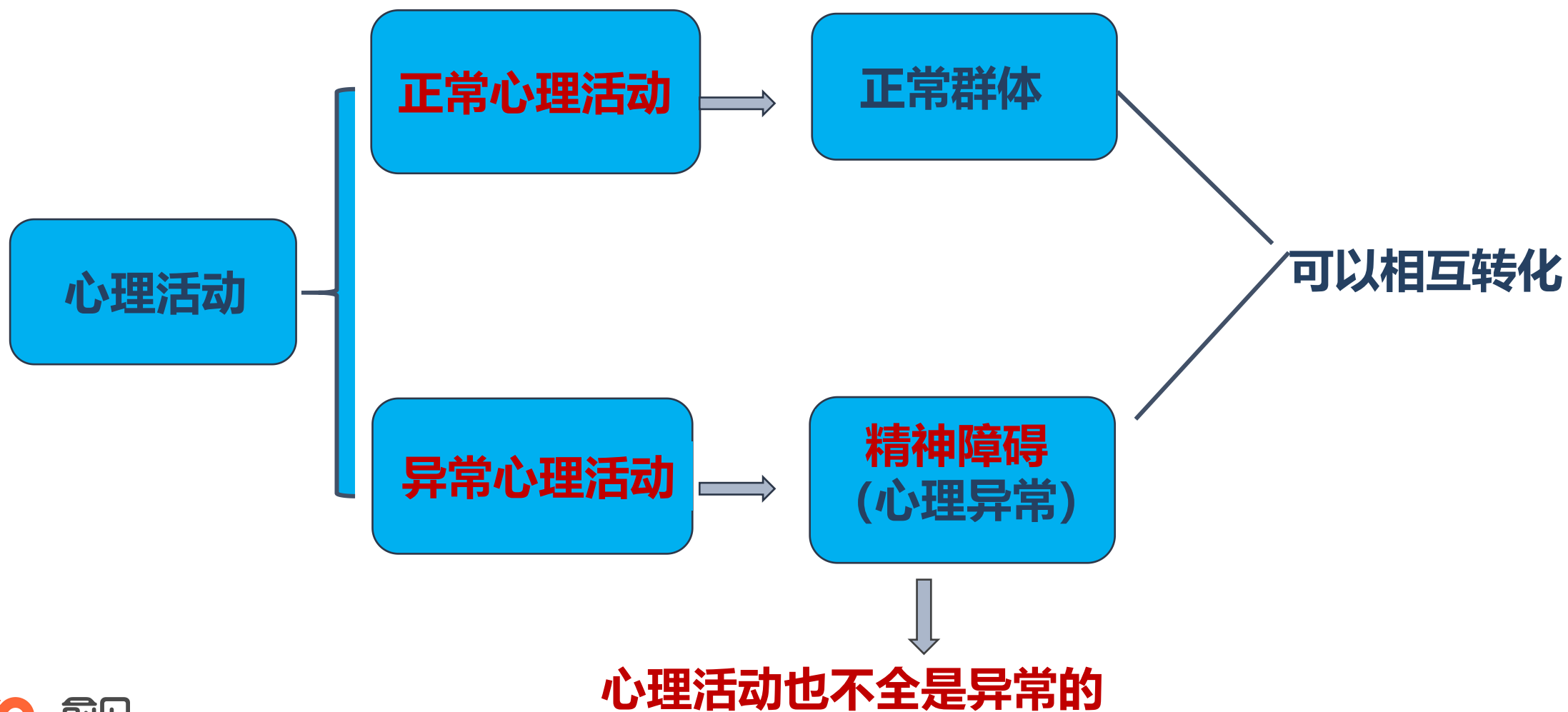
C O N T E N T S

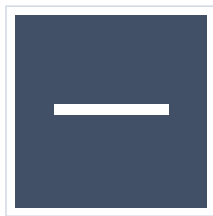


正常心理活动的功能



心理正常与心理异常的区分





正常心理活动的功能

多选

考点P9

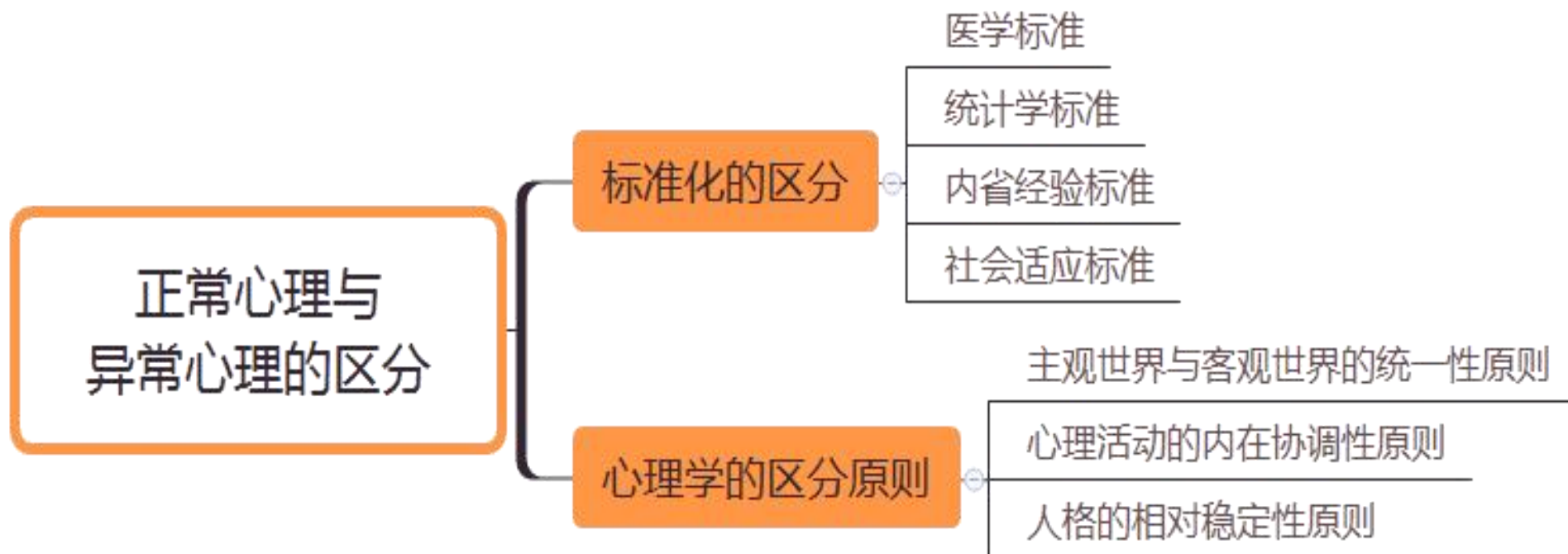
正常心理活动的功能

- 1、保障人**顺利地适应环境**，健康地生存发展；（**生物层面**）
- 2、保障人**正常地反映、认识客观世界**的本质及其规律性。（**个体层面**）
- 3、保障人**正常地进行人际交往**，在家庭、社会团体、机构中正常地肩负责任，使社会组织正常运行；（**社会性层面**）



心理正常与心理异常的区分

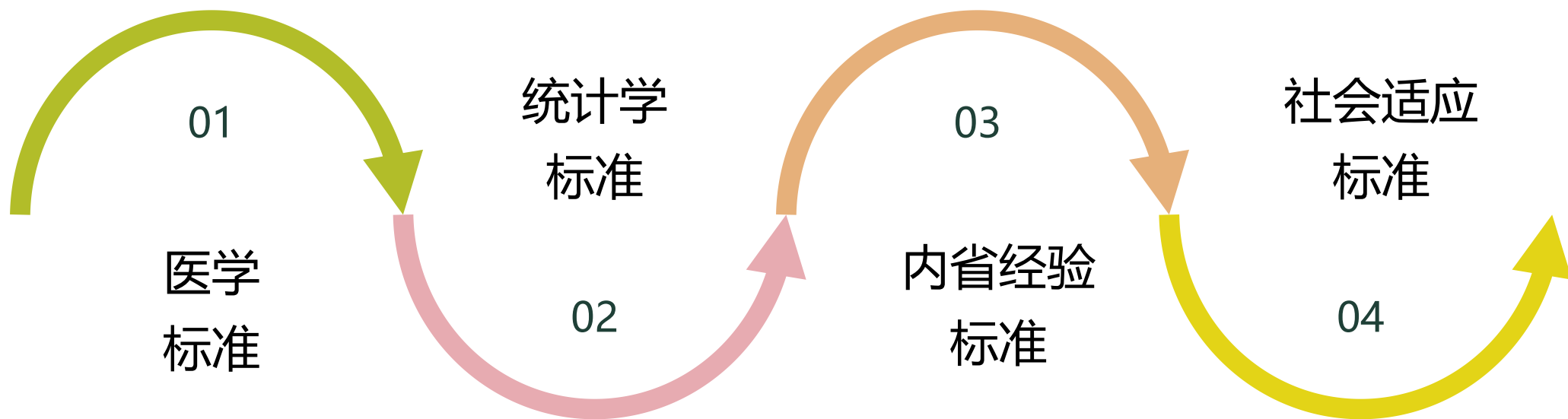
心理正常与心理异常的区分



多选

考点P10

一、标准化的区分（李心天）



一、标准化的区分

1.医学标准

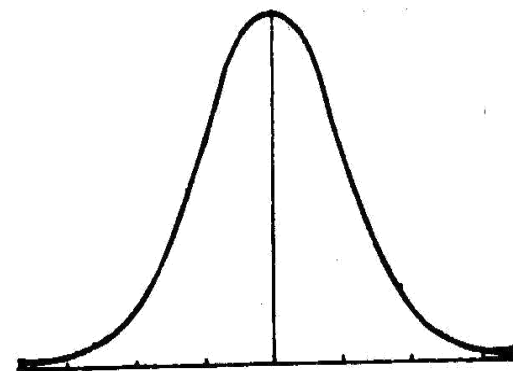
在医学标准下，精神障碍是躯体疾病，如果一个人的某种心理或行为被疑为有病，就必须找到它的病理解剖或病理生理变化的根据，在此基础上认定此人有精神障碍；其心理或行为表现，则被视为疾病的症状，其产生原因则归结为脑功能失调。

一、标准化的区分

考点P10

2.统计学标准

在普通人群中，人们的心理特征，在统计学上服从正态分布。这样，一个人的心理正常或异常，就可根据其**偏离平均值的程度**来决定。以统计数据为依据，确定正常与异常的界限，多以心理测验为工具。



一、标准化的区分

3.内省经验标准

1. **病人的内省经验**--病人自己觉得有精神或者情绪问题。
2. **观察者的内省经验**--观察者把被观察的行为与自己以往经验相比较，从而对被观察者做出心理正常还是异常的判断
(受主观性的影响)

一、标准化的区分

4.社会适应标准

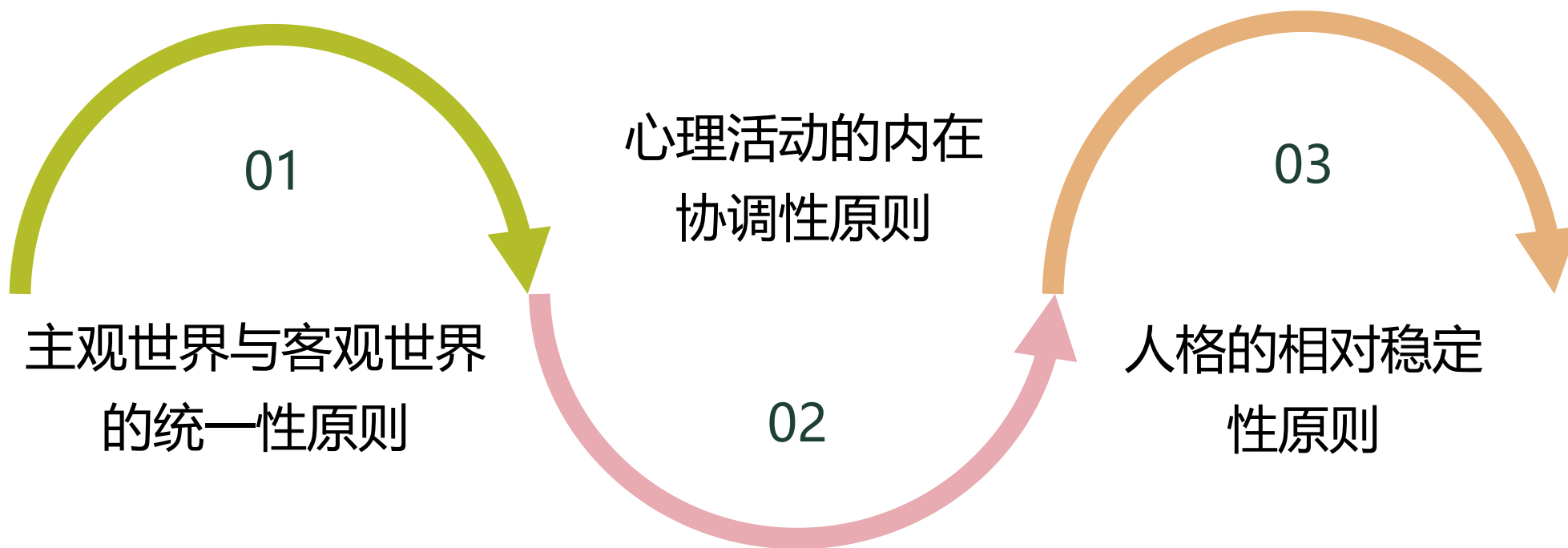
正常人的行为符合社会的准则，能根据社会要求和道德规范行事；异常心理的个体社会行为能力受损，不能按照社会认可的方式行事。

这一判断，是将此人的行为与社会行为相比较之后得出的。

多选

考点P11

二、心理学的区分原则（郭念峰）



二、心理学的区分原则

1. 主观世界与客观世界的统一性原则（内外统一）

因为心理是客观现实的反映，所以任何正常心理活动或行为，在形式和内容上必须与客观环境保持一致。

临床上常把有无 **“自知力”** 作为**判断精神障碍的指标**。

无自知力或自知力不完整：患者对自身状态的错误反映，或者说是自我认知”与“自我现实”的统一性的丧失。



二、心理学的区分原则

2. 心理活动的内在协调性原则（内在统一）

虽然人类的精神活动可以被分为知、情、意等部分，但是它自身是一个完整的统一体。

各种心理过程之间具有协调一致的关系，这种协调一致性，保证人在反映客观世界过程中的高度准确和有效。

二、心理学的区分原则

考点P11

3. 人格的相对稳定性原则（前后统一）

每个人都有自己独特的人格心理特征。这种人格心理特征一旦形成，便有相对的稳定性；在没有重大外界变革的情况下，一般是不易改变的。

如果**在没有明显的外部原因的情况下，一个人的人格相对稳定性出现问题**，我们也要怀疑这个人的心理活动出现了异常。

总结

第二节

心理正常与心理异常

什么是心理正常—正常心理活动的功能：

适应环境

人际沟通

主客观一致

什么是心理异常--正常心理活动功能的丧失

正常与异常 { 关系--相互转化

区别 { 标准化的“医统内社”
心理学的三“统一”

第三节 常见心理异常 的症状

C O N T E N T S



认知障碍



情绪障碍



意志行为障碍

心理过程 症状

认知障碍

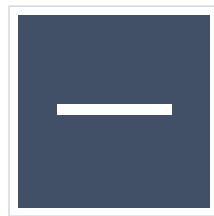
感知障碍--感觉障碍/知觉障碍/感知综合障碍
思维障碍--思维形式障碍/思维内容障碍
记忆障碍--记忆增强/记忆减退/遗忘/错构/虚构
意识障碍--注意障碍/智能障碍/自知力障碍

情绪障碍

以程度改变为主的情绪障碍--情绪高涨/情绪低落/焦虑/恐怖
以性质改变为主的情绪障碍--情绪迟钝/情绪淡漠/情绪倒错
脑器质性损害的情绪障碍--情绪脆弱/易激惹/强制性哭笑/欣快

意志行为障碍

意志体验障碍--意志增强/意志减退/意志缺乏
意志行为障碍--精神运动性兴奋/精神运动性抑制



认知障碍

一、感知障碍

(一) 感觉障碍

1. **感觉过敏**：由于病理性或功能性感觉阈限降低而对外界刺激的**过强反应**
2. **内感性不适**：躯体内部**性质不明确、位置不具体**的不舒适感，或难以忍受的异常感觉。多见于**精神分裂症、抑郁状态、神经症**和**脑外伤后综合征**
3. **感觉减退**：由于病理性或功能性感觉阈限增高而对外界刺激**的感觉迟钝**，此症状多见于**抑郁状态**、木僵状态和意识障碍患者，神经系统器质性疾病也常有感觉减退

一、感知障碍

(二) 知觉障碍

1. **错觉**：在特定条件下产生的、带有固定倾向的、对客观事物歪曲的知觉。病理性错觉**不能接受现实检验**。

2. **幻觉**：**无对象性**的知觉，感知到的形象不是由客观事物引起，并对此坚信不疑。（幻觉是一种很重要的精神病性症状）

一、感知障碍

(二) 知觉障碍

2. 幻觉

最常见

(1) 根据感觉器官的不同：**幻听**、幻视、幻嗅、幻味、幻触、内脏性幻觉。

耳 眼 鼻 口 肤 内

①幻听：包括言语性和非言语性幻听。

言语性幻听分为：1. 命令性幻听

2. 评论性幻听

3. 争论性幻听

一、感知障碍

(二) 知觉障碍

2. 幻觉

- ②**幻视**：缺乏具体形态和明确结构的幻视，叫做原始性幻觉。幻视也可以同外界事物的形象一样。
- ③**幻嗅**：经常嗅到异味感，如尸臭、轮胎烧焦后的气味等。
- ④**幻味**：患者在食物或水中，常尝到某种特殊的怪味道。
- ⑤**幻触**：患者常感到皮肤或粘膜上有虫爬、针刺、电灼等异常感觉。
- ⑥**内脏性幻觉**：患者躯体内部有性质很明确、部位很具体的异常知觉

内感性不适与内脏性幻觉

	内感性不适	内脏性幻觉
范畴	感觉症状	知觉症状
不适部位	不具体	具体
不适性质	不明确	明确

一、感知障碍

(二) 知觉障碍

2. 幻觉

(2) 按体验的来源：(是否与相应的感觉器官相联系)

①真性幻觉：与相应感觉器官相联系，形象清晰、生动，与客观事物一样，有相应的情绪和行为反应

②**假性幻觉**：不与相应感觉器官相联系，形象模糊、不生动，与客观事物不一样。**产生于患者的主观空间**，不是通过相应的感觉器官感知到的



一、感知障碍



(二) 知觉障碍

2. 幻觉

(3) 按产生的特殊条件:

- ①**功能性幻觉**: 在某个感觉器官处于功能活动状态的同时出现的幻觉。
- ②**思维鸣响**: 又称思维回响, 是特殊形式的幻觉, 患者能听到自己所思考的内容。
- ③**心因性幻觉**: 由强烈的精神刺激引发, 幻觉内容与精神刺激因素密切相关

多选

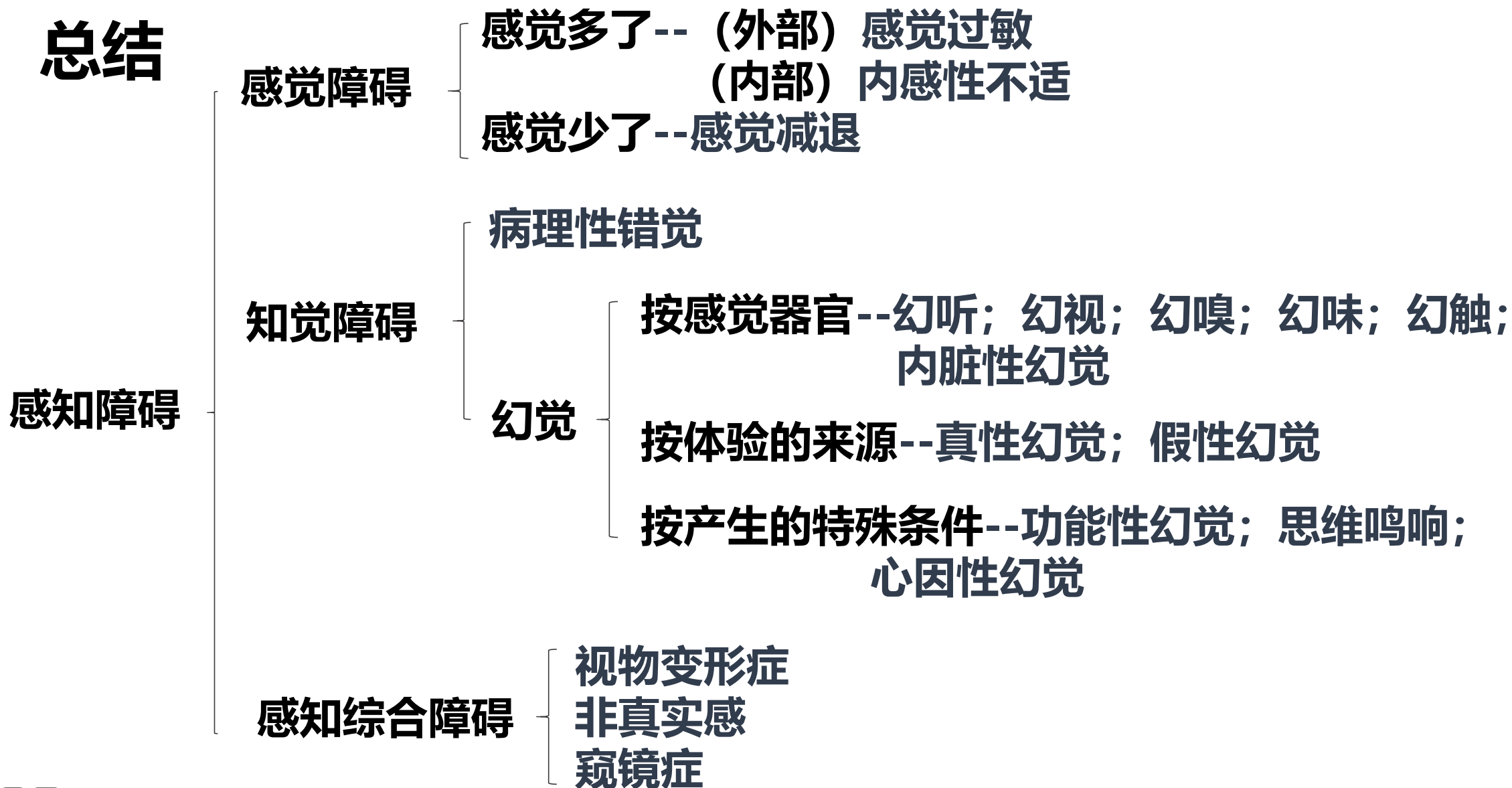
考点P16-17

一、感知障碍

(三) 感知综合障碍

- I. **视物变形症**：患者在感知客观事物的个别属性，如大小、长短、远近时发生变形，分为“视物显大症”、“视物显小症”。
- II. **非真实感**：患者感觉周围事物像布景、“水中月”“镜中花”，人物像油画中的肖像，没有生机。“非真实感”可见于**抑郁症、神经症和精神分裂症**。
- III. **窥镜症**：认为自己的面孔或体形改变了形状，自己的模样发生了变化，一日之内多次窥镜。

总结



二、思维障碍

考点P17-18

(一) 思维形式障碍

1.思维奔逸--思维速度过快

是兴奋性的思维联想障碍，**主要指思维活动量的增加和思维联想速度的加快**。患者语量多，语速快，**口若悬河，滔滔不绝**，词汇丰富，诙谐幽默。

2.思维迟缓--思维速度过慢

是抑制性的思维联想障碍，与思维奔逸相反，思维活动显著缓慢、联想困难、思考问题吃力、**反应迟钝**；语量少、**语速慢**。

二、思维障碍

考点P18、20

(一) 思维形式障碍

3.思维贫乏--使用概念过少

患者思想内容空虚，概念和词汇贫乏，回答得非常简单，**语速不慢**。

10.病理性赘述--使用概念过多

患者不能简洁明了的交谈，夹杂很多不必要细节，常见于**脑器质性精神障碍**。

二、思维障碍

考点P18-19

(一) 思维形式障碍

4.思维松弛--答非所问

思维联想松弛、内容散漫。回答不中肯、不切题，答非所问。

5.破裂性思维--意识清醒下的词语杂拌

主题之间、语句之间、词句之间缺乏应有的连贯性和逻辑性，支离破碎。

6.思维不连贯--意识障碍下的词语杂拌

二、思维障碍

考点P19-20

(一) 思维形式障碍

7.思维中断--概念突然没了

思维过程在短暂时间内突然中断，言语常在明显不应该停顿的地方突然停顿。

8.1.思维插入--他人的概念插入

8.2.思维被夺--概念被他人夺走

患者还有**属于自己的**、受自己意愿支配的思维活动。

9.思维云集--大量无关概念插入

又称强制性思维，指一种不受患者意愿支配的思潮，强制性地大量涌现在脑内。患者已经**没有属于自己的**思维活动了。



二、思维障碍

(一) 思维形式障碍

11. 病理性象征性思维

患者主动将普通概念和动作表示特殊含义。

12. 语词新作

患者自己创造一些文字、图形或符号，赋予特殊含义。

13. 逻辑倒错性思维

患者推理过程荒谬，但坚持已见。

总结

思维障碍

思维形式障碍

1. 思维奔逸 ——思维速度过快
2. 思维迟缓 ——思维速度过慢
3. 思维贫乏 ——使用概念过少
10. 病理性赘述 ——使用概念过多
4. 思维松弛 ——答非所问
5. 破裂性思维 ——意识清醒下的语词杂拌
6. 思维不连贯 ——意识障碍下的语词杂拌
7. 思维中断 ——概念突然没了
- 8.1. 思维插入 ——他人的概念插入
- 8.2. 思维被夺 ——概念被他人夺走
9. 思维云集 ——大量无关概念插入
11. 病理性象征性思维
12. 语词新作
13. 逻辑倒错性思维

思维内容障碍

二、思维障碍

(二) 思维内容障碍



妄想



强迫观念



超价观念

二、思维障碍

(二) 思维内容障碍

1. 妄想

(2) 妄想的种类（按主要内容）

- ①**关系妄想**：把现实中与自己无关的事情认为与本人有关。
- ②**被害妄想**：坚信周围某人对自己进行跟踪、监视等谋财害命活动。
- ③**特殊意义妄想**：周围人的言行与他有关，有特殊意义。
- ④**物理影响妄想**：自己的知、情、意受到外界某种力量支配，不能自主。
- ⑤**夸大妄想**：夸大自己的财富、地位、权利、能力等。

二、思维障碍

(二) 思维内容障碍

1. 妄想

(2) 妄想的种类（按主要内容）

- ⑥**自罪妄想**：毫无根据地认为自己犯了严重罪行，应被惩罚。
- ⑦**疑病妄想**：坚信自己患了某种严重躯体疾病，到处求医。
- ⑧**嫉妒妄想**：坚信**配偶**对其不忠，另有外遇，跟踪监视。
- ⑨**钟情妄想**：坚信异性对自己产生了爱情，将拒绝当作考验。
- ⑩**内心被揭露感（被洞悉感）**：认为自己内心的想法或者家人的隐私，未经表达就被他人得知。

多选

点P23

二、思维障碍

(二) 思维内容障碍

1. 妄想

(3) 妄想的种类（按照妄想的起源以及与其他精神症状的关系分类）

① **原发性妄想**：突然发生的，内容不可理解，与既往经历和当前处境无关，也不是起源于其他精神异常的一种病态信念。

A. 突发性妄想：妄想的产生非常突然，找不到任何心理学上的解释。

B. 妄想知觉：患者突然对正常知觉体验赋予妄想性意义。

C. 妄想心境：患者对他所熟悉的环境突然感到气氛不对，周围环境发生了某种对他不利的变化。 **（被害妄想）**

二、思维障碍

多选

考点P24

(二) 思维内容障碍

2. 强迫观念

强迫观念： 又称强迫性思维，指某一种观念或概念反复地出现在患者的脑海中。（明知不必，想摆脱但又摆脱不了，很苦恼）。

主要表现形式： 强迫性回忆、强迫性穷思竭虑、强迫性计数、强迫性怀疑、强迫性对立观念。

鉴别： 强迫性思维VS强制性思维



强迫性思维（强迫观念）与强制性思维（思维云集）

处于强迫性思维的患者，头脑中观念是他自己的，他有自己的主观意志——一种是想这样，另一种是不想这样。

处于强制性思维的患者，头脑中有大量的杂乱观念。患者报告这些观念都不是他自己的，没有自己的主观意志。

总结

思维内容障碍

妄想

按妄想的主要内容

1. 关系妄想--与我无关的妄想成有关的
2. 被害妄想--妄想他人总想伤害我
3. 特殊意义妄想--无关的妄想成有特殊意义的
4. 物理影响妄想--妄想某个物理的东西对自己有影响
5. 夸大妄想--妄想我自己很厉害
6. 自罪妄想--妄想自己有罪
7. 疑病妄想--妄想自己有病
8. 嫉妒妄想--妄想他人与自己的配偶有关系
9. (被) 钟情妄想--妄想他人都喜欢我
10. 内心被揭露感或被洞悉感--妄想他人能知道自己所想

按妄想的起源

原发性妄想 继发性妄想

- 突发性妄想--突然产生了某个观念
- 妄想知觉--突然产生了某种解释
- 妄想心境--突然感觉气氛不对环境不利

强迫观念：强迫性回忆、强迫性计数、强迫性对立等

超价观念

三、注意障碍、记忆障碍与智能障碍

考点P25

(一) 注意障碍

注意不是一种独立的心理过程，感知觉、思维、记忆、智能活动等等之所以能够正常进行，均需要注意的参与，因此**注意是一切心理活动共有的属性。**

注意对判断个体是否患有意识障碍有重要意义，意识障碍的患者通常**伴随有注意障碍。**

三、注意障碍、记忆障碍与智能障碍

考点P25

(一) 注意障碍

01

注意减弱

患者主动注意和被动注意的兴奋性减弱。

注意容易疲劳，注意力不容易集中，记忆力受到不好的影响。

02

注意狭窄

患者的注意范围显著缩小，**主动注意减弱**。

当注意集中于某一事物时，不能再注意与之有关的其他事物。常见于**激情状态**。

三、注意障碍、记忆障碍与智能障碍

多选

考点P26

(二) 记忆障碍

3.遗忘

1.顺行性遗忘：患者不能回忆疾病发生以后一段时间内所经历的事情。

2.逆行性遗忘：患者忘掉受伤前一段时间的经历。它的长度是指由受伤一刻开始，直至受伤前最后一件能清晰回忆的事情为止。

3.心因性遗忘：对生活中某一特定阶段的经历完全遗忘，通常与这一阶段发生的不愉快事件有关。

三、注意障碍、记忆障碍与智能障碍

(二) 记忆障碍

多选

考点P26

4. 错构

错构是记忆的**错误**，对过去曾经历过的事情在发生的时间、地点、情节上出现错误的回忆，并坚信不疑。

5. 虚构

患者在回忆中，把过去事实上**从未发生过的事情**，说成是确有其事。

当患者同时出现**记忆减退（特别是近记忆力减退）、错构、虚构以及定向力发生障碍时**，则被称之为**柯萨可夫综合征**，又称**遗忘综合征**。

三、注意障碍、记忆障碍与智能障碍

考点P27

多选

(三) 智能障碍

精神发育迟滞

先天或围生期或在生长发育成熟以前，由于**多种致病因素**的影响，使**大脑发育不良**或发育受阻，以致智能发育停留在某一阶段。

痴呆

是意识清楚情况下**后天获得的记忆、智能的明显受损**。

假性痴呆：无器质性损害、由心理应激引起，预后较好。

四、自知力障碍

自知力：指患者对其自身精神病态的认识和批判能力。

神经症：有自知力，常主动求医

精神障碍患者：无自知力，多不主动求医

自知力是精神科用来判断患者是否有精神障碍、精神障碍的严重程度以及疗效的重要指标。

总结

记忆障碍

记忆增强（记多了）——对无关细节的记忆显著增多

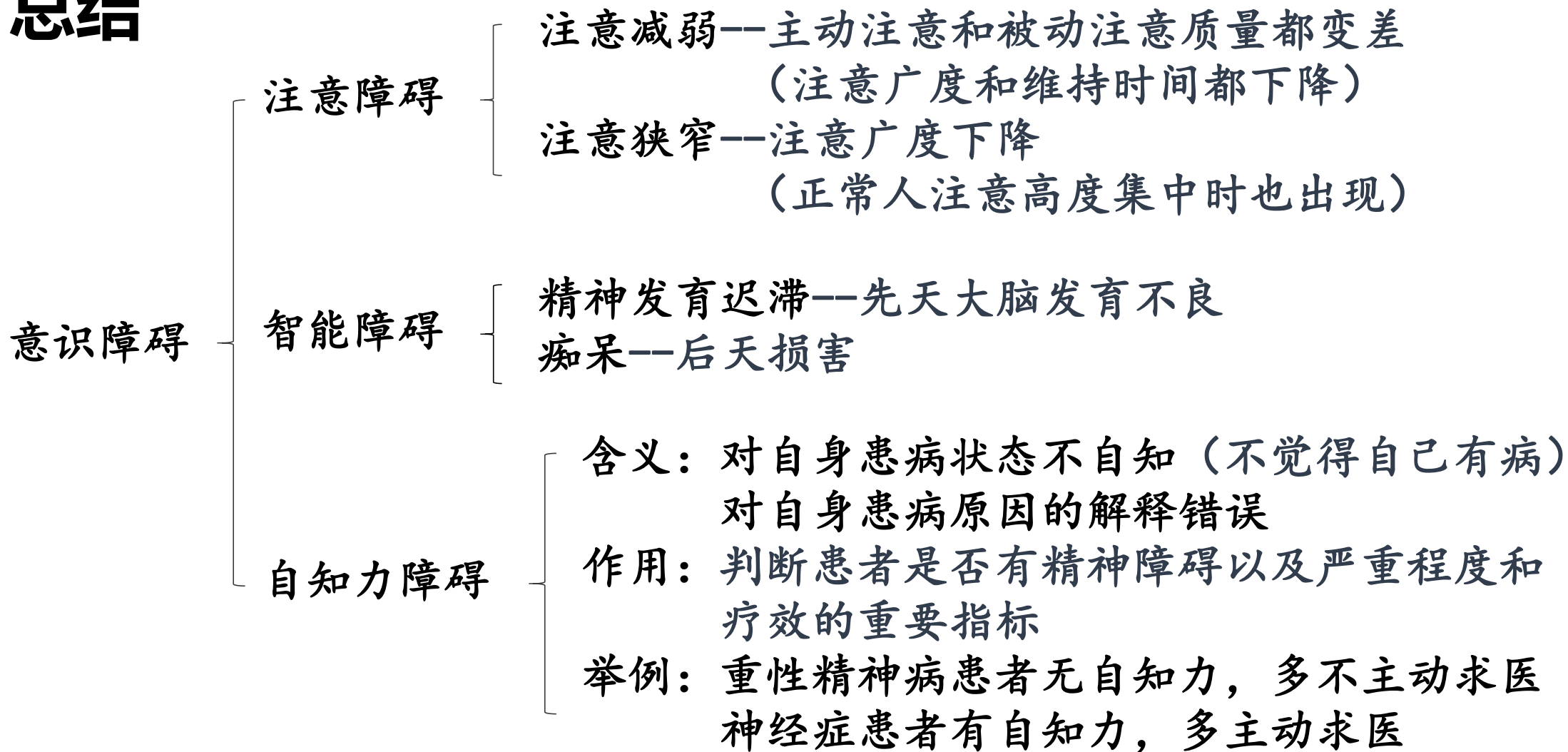
记忆减退（记少了）——远/近记忆力，需要更多努力才能记住

遗忘（记忆没了）——顺行性遗忘/逆行性遗忘/心因性遗忘

错构（记错了）——记忆中的这件事儿，曾真实发生过，但记忆细节出错了

虚构（瞎编的）——记忆中的这件事儿，根本没发生过

总结





情绪障碍

专栏：关于焦虑 (Freud)

多选

A 客体性焦虑 (恐惧)

又称现实性焦虑。
危险来自**自我**。

B 神经性焦虑

神经性焦虑是**意识不到**的焦虑，是阻抑于无意识的焦虑，造成焦虑的**威胁来自本能冲动**。

C 道德性焦虑

道德性焦虑的患者认为危险来自**超我**，被体验为耻感和罪感。

多选

专栏：关于焦虑 (Freud)

焦虑症状包括三个方面

A 与处境不相称的痛苦情绪体验，典型形式**漂浮焦虑或无名焦虑**。

B **精神运动性不安**。坐立不安、来回走动，甚至奔跑喊叫，不自主的发抖等。

C 伴有身体不适感的**植物神经功能障碍**。如出汗、胸闷气短、恶心呕吐等。

二. 以性质改变为主的情绪障碍

情绪
迟钝

对一般情况下，能引起鲜明情绪反应的事情反应平淡，缺乏相应的情绪反应。

高级的、人类特有的、很精细的情绪逐渐受损。

情绪
淡漠

对能引起正常人情绪波动的事情以及**与自己切身利益有密切关系的事情**，缺乏相应的情绪反应。

情绪
倒错

情绪反应与现实刺激的**性质不相称**。

三. 脑器质性损害的情绪障碍

考点P32

01

易激惹

因为一些细小的事情而引起强烈的情绪反应。

03

欣快

在痴呆基础上的一种“情绪高涨”。

情绪脆弱

因为一些细小或无关紧要的事情而伤心落泪或兴奋激动，无法克制。

02

强制性哭笑

没有外界因素的影响下，突然出现不能控制的、没有丝毫感染力的面部表情。

04

总结

情绪障碍

以程度改变为主的情绪障碍——情绪高涨/情绪低落/焦虑/恐怖

以性质改变为主的情绪障碍——情绪迟钝/情绪淡漠/情绪倒错

脑器质性损害的情绪障碍——情绪脆弱/易激惹/强制性哭笑/欣快



意志行为障碍

一. **意志增强**：意志活动的增多，但常常虎头蛇尾。

二. **意志缺乏**：患者缺乏应有的主动性和积极性，行为被动，生活极端懒散，个人及屋室卫生极差。

三. **意志减退**：意志活动的减少。

第一种情况是**抑郁状态**，受情绪低落的影响。

第二种情况是**意志减退**，程度较轻的意志缺乏，意志低下患者。

相同点：意志活动的减少。

不同点：**内心情绪体验不同**。

四. 精神运动性兴奋:

1. 协调性精神运动性兴奋

患者动作和行为的增加与思维、情绪活动和环境协调一致

2. 不协调性精神运动性兴奋

患者的动作、行为增多与思维及情绪不相协调

五. 精神运动性抑制

1. **木僵**：不言不语、不吃不喝、不动。
2. **违拗**：**主动性违拗**（做出与要求完全相反的动作）；
被动性违拗（不做出任何反应）。
3. **蜡样屈曲**：不仅表现为木僵状态，而且肢体任人摆布。
4. **缄默**：缄默不语，不回答问题，有时用手势或点摇头、写字与人交流。
5. **被动性服从**：被动地服从医生或其他人的命令和要求。

多选

考点P35-36

五. 精神运动性抑制

- 6. **刻板动作**：机械、刻板地重复某单调动作，常与刻板言语同时出现。
- 7. **模仿动作**：无目的地模仿别人的动作，常与模仿言语同时出现。
- 8. **意向倒错**：意向活动与一般常情相违背。
- 9. **作态**：会做出幼稚愚蠢、古怪做作的姿势、动作、步态或表情。
- 10. **强迫动作**：作出违反本人意愿且反复出现的动作，患者感到非常痛苦。

总结

意志行为障碍

意志增强——增多

意志缺乏——缺乏主动性

意志减退——减少

精神运动性兴奋——协调性精神运动性兴奋/
不协调性精神运动性兴奋

精神运动性抑制——木僵/违拗/蜡样屈曲/缄默/
被动性服从/刻板动作/模仿
动作/意向倒错/作态/强迫动作

第四节 常见的精神障碍

C O N T E N T

一

精神分裂症及其他妄想性障碍

二

心境障碍

三

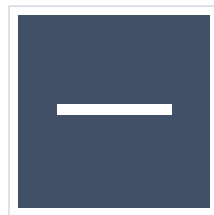
神经症性、应激相关及躯体形式障碍

四

心理生理障碍

五

人格障碍



精神分裂症及其他妄想性障碍



多选



考点P39

一、精神分裂症

一种病因未明的常见精神障碍，具有感知、思维、情感、行为等多方面障碍。

- ◆ 以**精神活动不协调**和**脱离现实**为特征
- ◆ 通常能维持**清晰的意识和基本智力**，但某些认知功能会出现障碍
- ◆ **多起病于青壮年**，常缓慢起病，**病程迁延**
- ◆ **发作期自知力基本丧失**

多选

考点P40

二、妄想性障碍

又称**偏执性精神障碍**，出现单一的或一整套相关的妄想，并且这种妄想通常是持久的，甚至终身存在。

- ◆ 妄想**内容有一定的现实性**，并不荒谬
- ◆ **个别伴有幻觉**，但历时短暂而不突出
- ◆ **病前人格多具固执、主观、敏感、猜疑、好强**等特征
- ◆ **病程发展缓慢**

多选

考点P40

三、急性短暂性精神障碍

- ◆ 两周内急性起病
- ◆ 以精神病性症状为主
- ◆ 起病前有相应的心因
- ◆ 在2-3个月内可完全恢复



总结

精神分裂症及其他妄想性障碍

精神分裂症

1. 以精神活动的不协调和脱离现实为特征;
2. 多起病于青壮年;
3. 起病缓慢, 病程迁延;
4. 发作期自知力基本丧失;
5. 幻觉妄想为主要症状。

妄想性障碍 (偏执性精神障碍)

1. 妄想内容有一定的现实性, 并不荒谬;
2. 个别可伴有幻觉, 但历时短暂而不突出;
3. 病前人格多具有固执、主观、敏感、猜疑、好强等特征;
4. 病程发展缓慢。

急性短暂性精神障碍

1. 在两周内急性起病;
2. 精神病性症状为主;
3. 起病前有相应的心因;
4. 在2-3个月内可完全恢复。



心境障碍

多选

考点P42

一. 躁狂发作

主要特点：情绪高涨、思维奔逸、精神运动性兴奋

二. 抑郁发作

主要特点：情绪低落、思维缓慢、语言动作减少和迟缓

三. 双相障碍

主要表现：情绪高涨与情绪低落交错发作

四. 持续性心境障碍

主要特点：持续性并常有起伏的心境障碍，每次发作极少严重到足以描述为轻躁狂，甚至不足以达到轻度抑郁



总结

心境障碍

躁狂发作——特点：情绪高涨、思维奔逸、精神运动性兴奋。

抑郁发作——特点：情绪低落、思维缓慢、语言动作减少和迟缓。

双相障碍——特点：情绪高涨与情绪低落交错发作。

持续心境障碍——特点：持续性并常有起伏的心境障碍，每次发作极少严重到足以描述为轻躁狂，甚至不足以达到轻度抑郁。



神经症性、应激相关及躯体形式障碍

一、神经症性障碍

(一) 神经症性特点与临床评定方法

神经症

神经症是一种精神障碍，主要表现为**持久的心理冲突**，病人**觉察到**或体验到这种冲突并因之而**深感痛苦**且妨碍心理功能或社会功能，但**没有任何可证实的器质性病理基础**。

多选

考点P43-45

神经症的五个特点：久知苦、身未病、社受损

01

精神痛苦

意识的
心理冲突

03

心理功能或社
会功能受损

持久性

05

无器质性病
变为基础

02

04

心理冲突的类型：

心理冲突的常形：

- ①与现实处境直接相联系，涉及大家公认的重要生活事件
- ②有明显的道德性质

VS

心理冲突的变形：

- ①与现实处境没有什么关系，或涉及的是鸡毛蒜皮的小事
- ②不带明显的道德色彩

心理冲突的变形是神经症性的，而心理冲突的常形则是大家都有经验。

考点 P44-45

打分（许又新）：

总分=3分，不能诊断为神经症

总分=4或5分，可诊断为神经症性心理问题（可疑神经症）

总分 ≥ 6 分，可诊断为神经症

人际关系
(聚会)
工作效率

	1分	2分	3分
病程	不到3个月	3个月到1年	1年以上
痛苦程度	自愈	他助	无法
社会功能	轻微	显著（减半）	严重（停止）

多选

二、应激相关障碍

(一) 急性应激障碍

患者在遭受急剧、严重的精神打击后，在**数分钟或数小时内**发病，病程为**数小时至数天**。

主要表现：意识障碍、意识范围狭窄、**定向障碍**，言语缺乏条理，对周围事物感知迟钝；可出现**人格解体**，有**强烈恐惧**，精神运动性兴奋或精神运动性抑制。

二、 应激相关障碍

(二) 创伤后应激障碍 (PTSD)

又称延迟性心因性反应，是指患者在遭受强烈的或灾难性**精神创伤**实践后，**延迟出现、长期持续**的精神障碍。

潜伏期可从数周到数月不等。

病程呈波动性，多数可恢复。

多选

➔ 创伤后应激障碍的表现

第一，**创伤性体验反复重现**。闯入性重现（闪回）

第二，对创伤性经历的选择性遗忘

第三，在**麻木感**和**情绪迟钝**的持续背景下，发生与他人疏远、对周围环境漠无反应、快感缺失、回避易联想起创伤经历的活动和情境。即痛苦情绪由一开始针对创伤经历，**泛化**到与他人的交往和对周围环境的反应上

第四，常有**植物神经过度兴奋**，伴有过度警觉、失眠。

第五，**焦虑和抑郁**与上述表现伴随，可有自杀观念。

二、 应激相关障碍

(三) 适应障碍

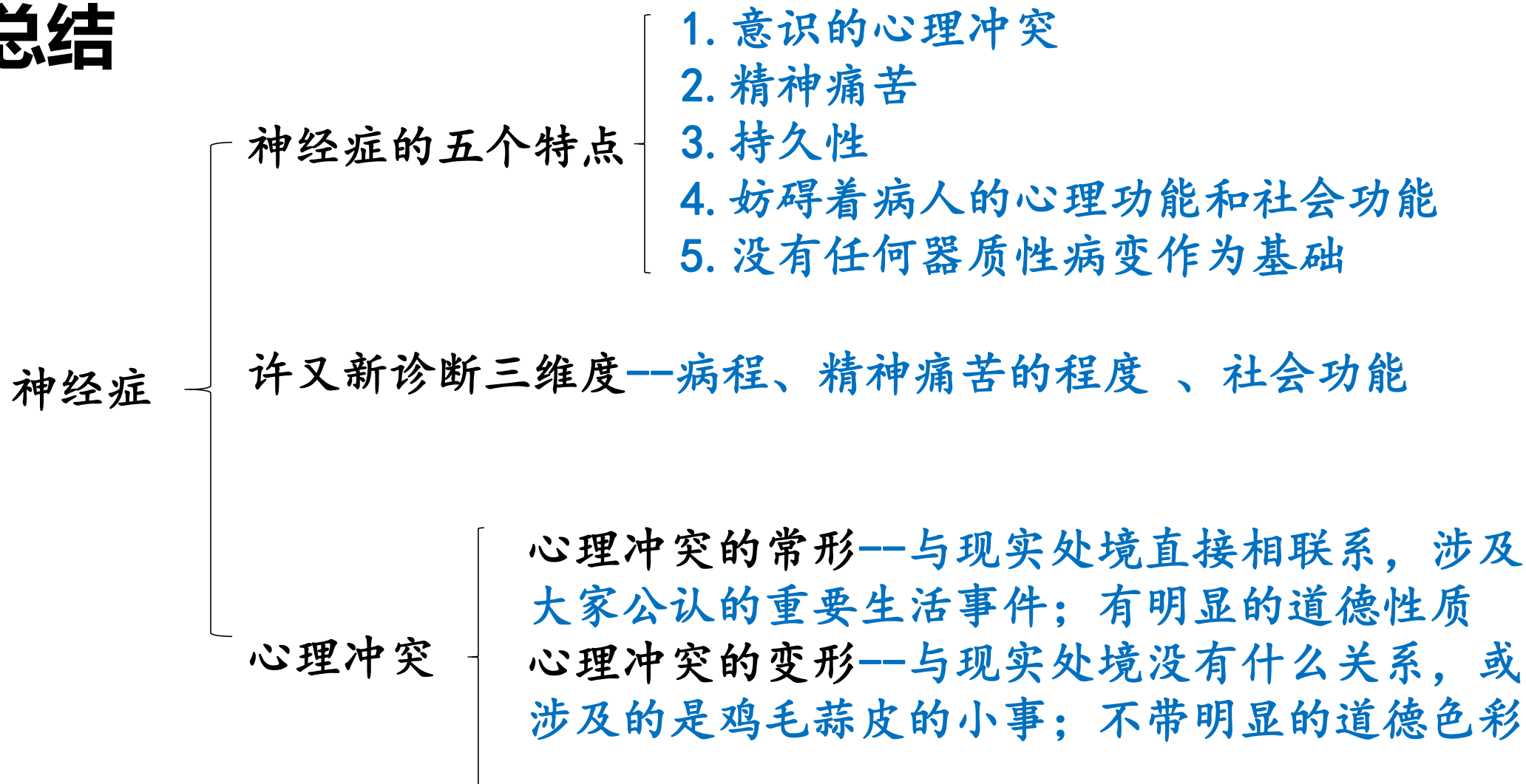
在重大的生活改变或应激性生活事件的适应期，出现的主观痛苦和情绪紊乱状态，常会影响社会生活和行为表现。

通常在遭遇生活事件后**1个月内**起病，病程一般**不超过6个月**。

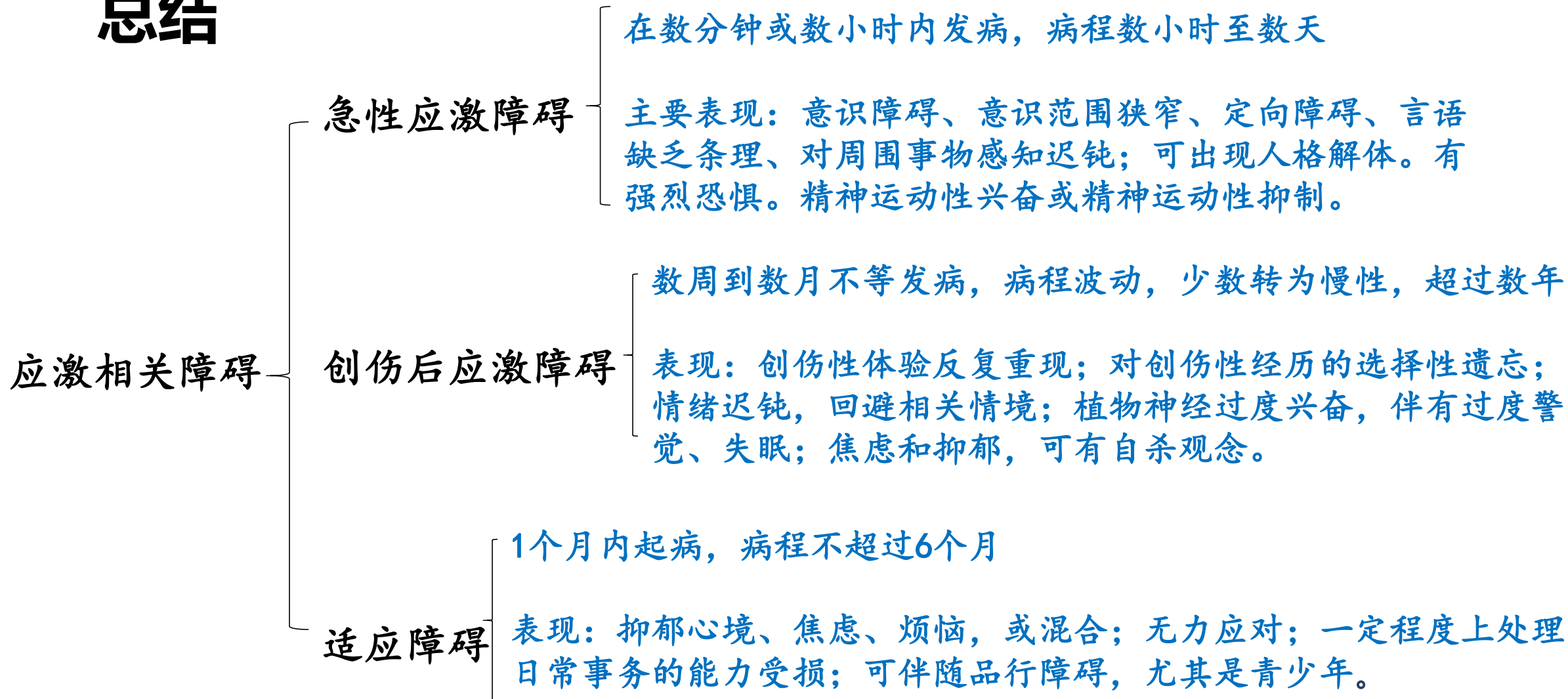
各种应激障碍的发病时间与病程

	发病	病程
急性应激障碍	数分钟数小时（一天内）	数小时数天（一周内）
适应障碍	1个月内	半年内
创伤后应激障碍（PTSD）	数周数月	数年

总结



总结





心理生理障碍

多选

与心理因素相关、以生理活动异常为表现形式的精神障碍。

①**进食障碍**

神经性厌食
神经性贪食
神经性呕吐

②**睡眠障碍**

失眠症、嗜睡症、
睡行症、夜惊、梦魇

③**性功能障碍**

性欲减退、阳痿、早泄、
性高潮缺乏、阴道痉挛、
性交疼痛



人格障碍

在个体发育成长过程中，因遗传、先天以及后天不良环境因素造成的个体心理与行为的持久性的固定行为模式，这种行为模式偏离社会文化背景，并给个体自身带来痛苦，或贻害周围。

心理咨询和治疗对人格障碍的**作用有限**。

➔ A型人格障碍（古怪的、奇怪的）

- ①**偏执型人格障碍**：以**猜疑和偏执**为特点。
- ②**分裂样人格障碍**：**观念、行为、外貌装饰奇特，情绪冷漠，人际关系有明显缺陷。**
- ③**分裂型人格障碍**：对亲密关系感到强烈不适，建立亲密关系能力下降，且伴有认知或知觉扭曲和古怪行为特点。

➡ B型人格障碍（戏剧化的，情绪化的，反复无常的行为）

- ④ 反社会型人格障碍：常违法乱纪，不符合社会规范，对人冷酷无情
- ⑤ 边缘型人格障碍：人际关系、自我形象和情感不稳定以及显著冲动
- ⑥ 表演型人格障碍：又称**癔症性人格障碍**，过分感情用事或夸张言行吸引他人注意。
- ⑦ 自恋型人格障碍：需要他人赞扬且缺乏共情的自大

多选

考点P56

➔ C型人格障碍（焦虑恐惧的，和焦虑障碍患者有相同的特征）

- ⑧ 强迫型人格障碍：过分的谨慎小心，严格要求与完美主义及内心的不安全感。
- ⑨ 焦虑型人格障碍：一贯紧张、提心吊胆、不安全和自卑，习惯性夸大日常处境中的潜在危险。
- ⑩ 依赖型人格障碍：缺乏自信、不能独立活动。

总结

人格障碍

偏执性人格障碍——以猜疑和固执己见为特点

分裂样人格障碍——以观念、行为、外貌装饰奇特，情绪冷漠、人际关系明显缺陷为特点

反社会性人格障碍——以行为不符合社会规范，具有经常违法乱纪，对人冷酷无情为特点

冲动性人格障碍——以阵发性情绪爆发，伴明显冲动性行为为特征，又称攻击性人格障碍

表演性人格障碍——又称癔症性人格障碍，以过分感情用事或夸张言行吸引他人注意为特点

强迫性人格障碍——以过分要求严格与完美无缺为特征

焦虑性人格障碍——一贯感到紧张、提心吊胆、不安全和自卑，习惯性夸大日常处境中的潜在危险

依赖性人格障碍——依赖、不能独立解决问题

第五节 心理健康与 心理不健康

C O N T E N T S



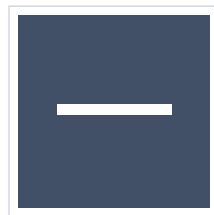
关于心理健康的定义



评估心理健康的标准



相关概念的区分和内涵



关于心理健康的定义

多选

考点P59

一、心理健康的定义

1. 第三届国际心理卫生大会认定的**心理健康的标志**是：

(1) 身体、智力、情绪协调；

(2) 适应环境；

(3) 有幸福感；

(4) 能充分发挥职业能力。

心理健康是指心理形式协调、内容与现实一致和人格相对稳定的状态



评估心理健康的标准

多选

考点P59

一、**许又新**提出可以用**三类标准**衡量心理健康。

(1) 体验标准。

(2) 操作标准。指**通过观察、实验和测验等方法考察心理活动的过程和效应**，其核心是效率，主要包括个人心理活动的效率和个人的社会效率或社会功能。

(3) 发展标准。**着重对个体的心理发展状况进行纵向考察与分析并作为评价指标**

二、郭念锋提出评估心理健康水平的十个标准。

- (1) **心理活动强度**：指对于突然的强大精神刺激的抵抗能力。
- (2) **心理活动耐受力**：指对于慢性的、长期的精神刺激的抵抗能力。
- (3) 周期节律性：指人的心理活动也有自己内在的规律。
- (4) 意识水平 (5) 暗示性 (6) 康复能力 (7) 心理自控力 (8) 自信心
- (9) 社会交往 (10) 环境适应能力



相关概念的区分及内涵

一、概念的区分

心理正常：具备正常功能的心理活动，或者是不包含有精神障碍症状的心理活动。

心理异常：丧失了正常功能的心理活动，有典型精神障碍症状的心理活动。



一、概念的区分

心理健康与不健康的图示



对于是否有病，心理咨询和精神病学都很关心，前者主要是为了鉴别，后者主要是为了治疗。

理论上，心理咨询的主要工作对象是心理不健康状态。

多选

考点P63

二、健康心理和不健康心理的具体内涵

从静态的角度看：

是一种**心理状态**，在
某一时段内**展现着自
身的正常功能**。

健康心理

从动态的角度看：

围绕某一群体的心理健康
常模，在一定（两个标准
差）范围内不断上下波动
的**相对平衡**过程。

健康心理的内涵涵盖着一切**有利于个体生存发展**和稳定生活质量的心理活动。

多选

考点P64

三、心理不健康状态的分类

心理健康与不健康的图示



一般心理问题

严重心理问题

可疑神经症

神经症

总结

心理健康与 心理不健康

第三届国际心理卫生
大会心理健康的标准——

身体、智力、情绪十分协调；适应环境，人际关系中彼此谦让；有幸福感；在职业工作中，能充分发挥自己的能力，过着有效率的生活。

评估心理健康的三标准——体验标准、操作标准、发展标准。

评估心理健康的十标准——心理活动强度、心理活动耐受力等。

心理状态

心理正常

心理健康

心理不健康——一般心理问题、严重心理问题、神经症性心理问题

心理异常

健康心理

静态——心理状态、展现着自身的正常功能

动态——围绕常模上下波动

涵盖一切有利于个体生存发展和稳定
生活质量的心理活动。

第六节 心理不健康 状态的分类

C O N T E N T S



概述



心理不健康状态的分类

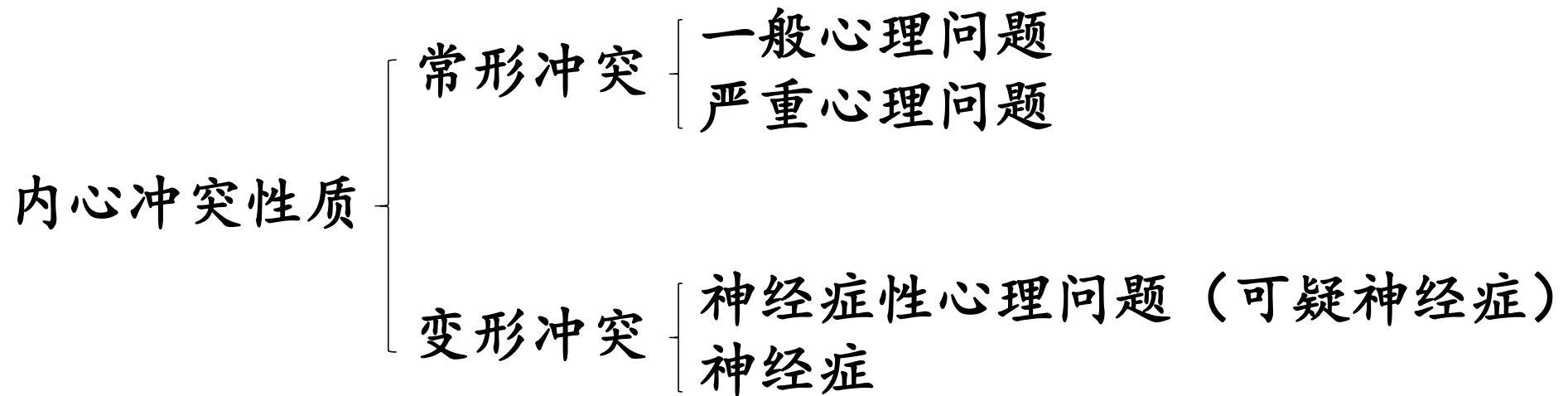


心理不健康的分类

心理健康与不健康的图示



内心冲突与诊断





		一般心理问题	严重心理问题
冲突性质	常形冲突		
持续时间		连续1个月以内 (近期发生) 断续2个月以内	2~6个月
引发事件		生活事件 (原因明确) (一般的夫妻矛盾) (一般的婆媳矛盾) (孩子的教育问题) (同事之间的矛盾) (工作的调动升迁)	强烈刺激 (重要关系的破裂, 如分手、离婚、失亲) (学业事业的失败, 如重要考试失败、失业) (道德法律问题, 如抚养赡养问题、家暴)
严重程度	是否泛化	分化, 仅由最初事件引发	泛化, 可由相似事件引发
	痛苦程度	自控, 自愈	失控, 他助
	社会功能受损程度	轻微 (反应不强)	显著

考点P69

多选

第七节 关于健康心理学

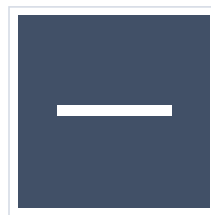
C O N T E N T S



概述



常见的躯体疾病患者的心理问题



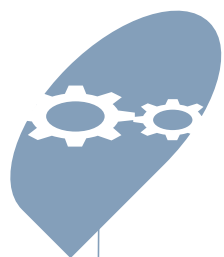
概述



健康心理学是“保健、诊病、防病和治疗的心理”

健康心理学侧重于研究伤害身体健康的生活方式和心理活动

健康心理学的工作领域:



疾病患者的
心理学问题

“有病”



躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的心理学问题

“治病”



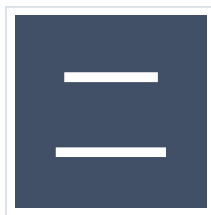
促进维护健康的心理学问题

“没病”



促进健康服务和健康服务政策的制定

“预防”



常见的躯体疾病患者的心理问题

一、躯体疾病患者的一般心理特点

多选

1

情感上的---情绪低落

2

认知上的---时间感觉发生变化
注意力从外界转移到自身的体验和感觉上

3

人格上的---精神偏离日常状态

4

态度上的---对客观世界和自身价值的态度发生改变

第 八 节

压力与健康

C O N T E N T S



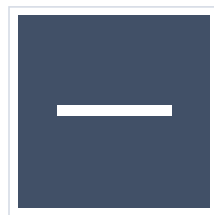
从心理学角度看压力



压力的适应



压力的临床后果和中介系统



从心理学角度看压力

一、压力的定义

- **压力**是指由压力源和压力反应共同构成的一种认知和体验过程
S(压力源)-O(压力认知和体验)-R(压力反应)
- **压力源**是现实生活要求人们去适应的事件。
- **压力反应**包括主体觉察到压力源后，出现的心理、生理和行为反应

二、压力源的种类

生物性压力源：直接影响**主体生存与种族延续**的事件。

举例：创伤或疾病、饥饿、性剥夺、睡眠剥夺、噪音、气温等。

精神性压力源：直接影响**主体正常精神需求的内在和外**在事件。

举例：错误的认知结构、个体不良经验、道德冲突、不良个性等。

社会环境性压力源：直接影响**主体社会需求**的事件。

1.纯社会性的压力源：重大社会变革、失恋、离婚、战争等。

2.由自身状况造成的人际适应问题：社交恐怖症、社会交往不良等。

三、压力源的测评

社会再适应量表

测量**重大生活事件**
遭遇者整体**免疫功能降低**
高分者易患心脏病、骨质疏松、糖尿病和精神障碍，
有局限性

日常生活中小困扰的测量

健康状况与小困扰出现的**频率和强度**有关
日常小压力比主要的生
活改变更能预测健康

知觉压力的测评

个体意识到现
实生活提出的
并**超出个人能
力**的事件

四、压力的内省体验



心理学中所说的压力，是**人的内心冲突**和**与其相伴随的强烈情绪体验**。



如果人对某件事是**漠不关心**的，那就构不成压力。

四、压力的内省体验

- 1931年，心理学家勒温和后来的心理学家米勒按冲突的形式，将内心冲突分为四类：**双趋冲突、趋避冲突、双避冲突、双重趋避冲突。**

多选

考点P79-80

四、压力的内省体验

01

趋避冲突

一个有吸引力的目标，但达到该目标却有极大危险

03

双重趋避冲突

由两种可能的选择引起，两种选择都是既有利又有弊时

双趋冲突

两件有强烈吸引力，又互不相容的事物出现时

02

双避冲突

一个人面临两种不利的情景

04

类型	含义	核心概念	示例
双趋冲突	两件有强烈吸引力，又互不相容的事物出现时	两个目标只能选其一	鱼与熊掌不可兼得
趋避冲突	一个有吸引力的目标，但达到该目标却有极大危险	同一目标既希望解决又希望回避	想吃鱼，又怕刺 嗜酒者不得不戒酒
双避冲突	一个人面临两种不利的情景	两个目标只能回避其一	前怕狼，后怕虎 既怕开刀，又怕吃药
双重趋避冲突	由两种可能的选择引起，两种选择都是既有利又有弊时	两个目标都是既吸引又排斥	大学毕业，去大城市，还是小城市？

总结

从心理学角度看压力

压力的含义：S-O-R

压力源的种类

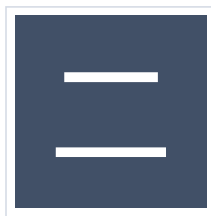
- 生物性压力源--影响生存
- 精神性压力源--影响幸福
- 社会性压力源--影响人际

压力源的测评

- 社会再适应量表--重大事件
- 日常生活中小困扰的测量--频率和强度
- 知觉压力的测评--超出个人能力

压力的内省体验

- 双趋冲突--两个选项，都好
- 趋避冲突--一个选项，好坏并存
- 双避冲突--两个选项，都坏
- 双重趋避冲突--两个选项，都好坏并存



压力的适应

一、压力的种类

考点P81

叠加性压力

- ▶ **同时性叠加**压力（四面楚歌）
- ▶ **继时性叠加**压力（祸不单行）

多选

单一性压力

- ▶ 经历某件事，并努力适应
- ▶ **后效不完全是负面**的

破坏性压力

- ▶ （飞来横祸）
- ▶ “创伤后应激障碍”



多选

二、压力的适应

一般性压力的适应-- “一般适应征候群”（塞利）

A

警觉阶段

发现了事件并引起警觉，同时准备战斗。**呼吸、心跳加速、汗腺加快分泌、血压、体温升高**等等。

B

搏斗阶段

- 生理、生化指标表面上恢复
- 个体内在生理和心理资源被大量消耗
- 个体变得**敏感、脆弱**，即使是日常**微小的困扰**，都可引发个体**强烈情绪反应**

C

衰竭阶段

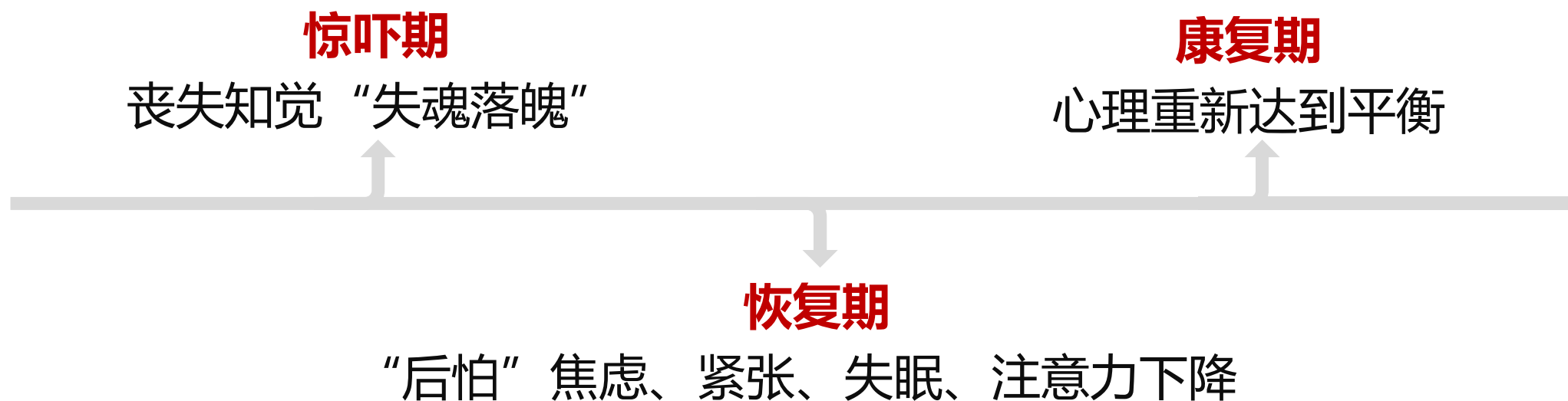
“筋疲力尽”
适应/危险

多选

考点P82

二、压力的适应

破坏性压力的适应-- **“灾难症候群”** (强大的自然灾害后的心理反应)



总结

压力的适应

压力的种类：一般单一性生活压力、叠加性压力、破坏性压力

一般适应征候群

警觉期：呼吸、心跳加速、汗腺加快分泌、血压、体温升高

搏斗期：个体变得敏感、脆弱，即使是日常微小的困扰，都可引发个体强烈情绪反应

衰竭期：生理心理筋疲力尽

灾难征候群

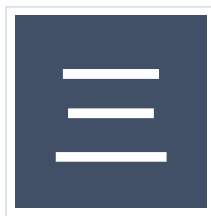
惊吓期：失魂落魄

恢复期：焦虑、紧张、失眠、注意力下降等，逢人便说自己的遭遇

康复期：心理重新达到平衡

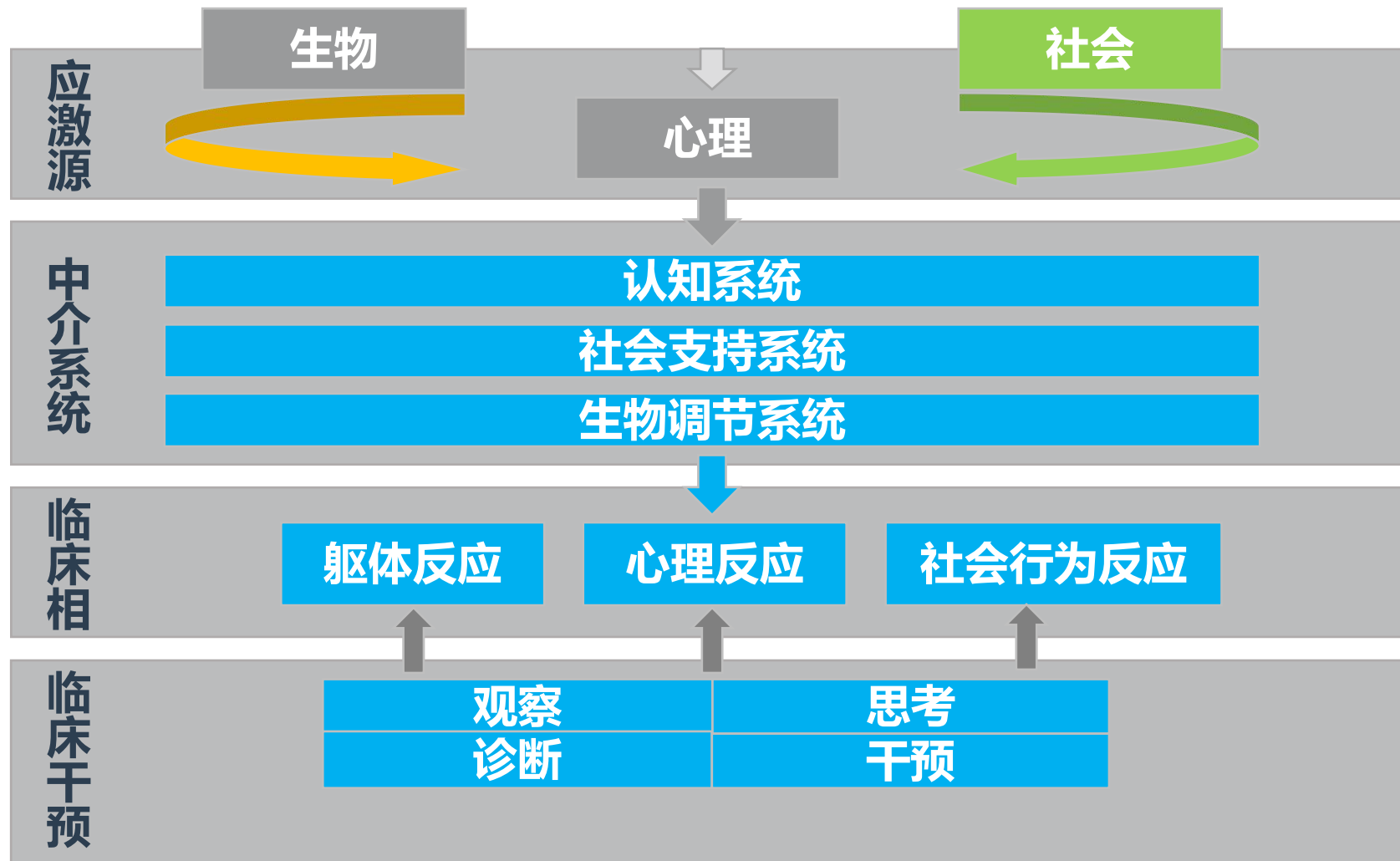


关注二维码
获取更多心理资讯

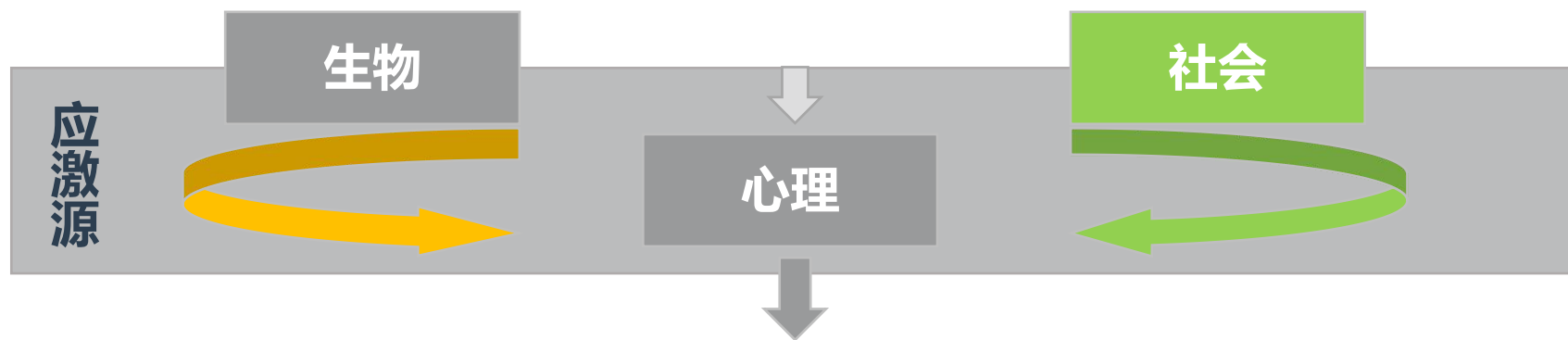


压力的临床后果和中介系统

二、从压力源到临床相的逻辑过程



(一) 对压力的响应阶段



客观上已经发生的事件，并不是都可以成为压力源。只有被个体觉察、与个体生活相关并**引起响应的事件**，才对个体构成压力
(**漠不关心**的心态不会产生压力体验)

(二) 中介系统的增益或消解过程

压力作用于个体后，并不直接表现为临床症状，而是进入中介系统，经过中介系统的**增益或消解**，事件的**相对强度**和性质可以产生某些改变。



(二) 中介系统的增益或消解过程

考点P86

1. 认知系统

拉扎鲁斯

(1) 认知评估

- ①认知的结果有两种可能--这是不是个事
- ②对事件严重性的评估--这是不是个大事
- ③对自己能力的评估--这事，我行不行

(2) 调节控制

- ①行为的自我控制
- ②认知的控制 --自我调节、自主控制
- ③环境的控制

(3) 人格

- ①**外控者**人格--我命由天不由己
- ②**内控者**人格--我命由己不由天

(二) 中介系统的增益或消解过程

2. 社会支持系统

亲密的和可信任的关系是压力的有效缓冲器

3. 生物调节系统

包括神经内分泌系统和**免疫系统**（最主要的）。

功能状态好，可以防止或降低应激后果的**躯体化症状**。

多选

(三) 临床相阶段



及时型的症状

响应压力后，经过中介系统的处理，**迅速表现**出的临床症状。

滞后型的症状

压力在中介系统中处理时，认知系统对事件的性质和意义评估模糊，作为潜在模糊观念积存起来。后来类似事件出现时，积存的模糊观念被激活并赋予新的意义。

总结

压力的临床 后果和中介系统

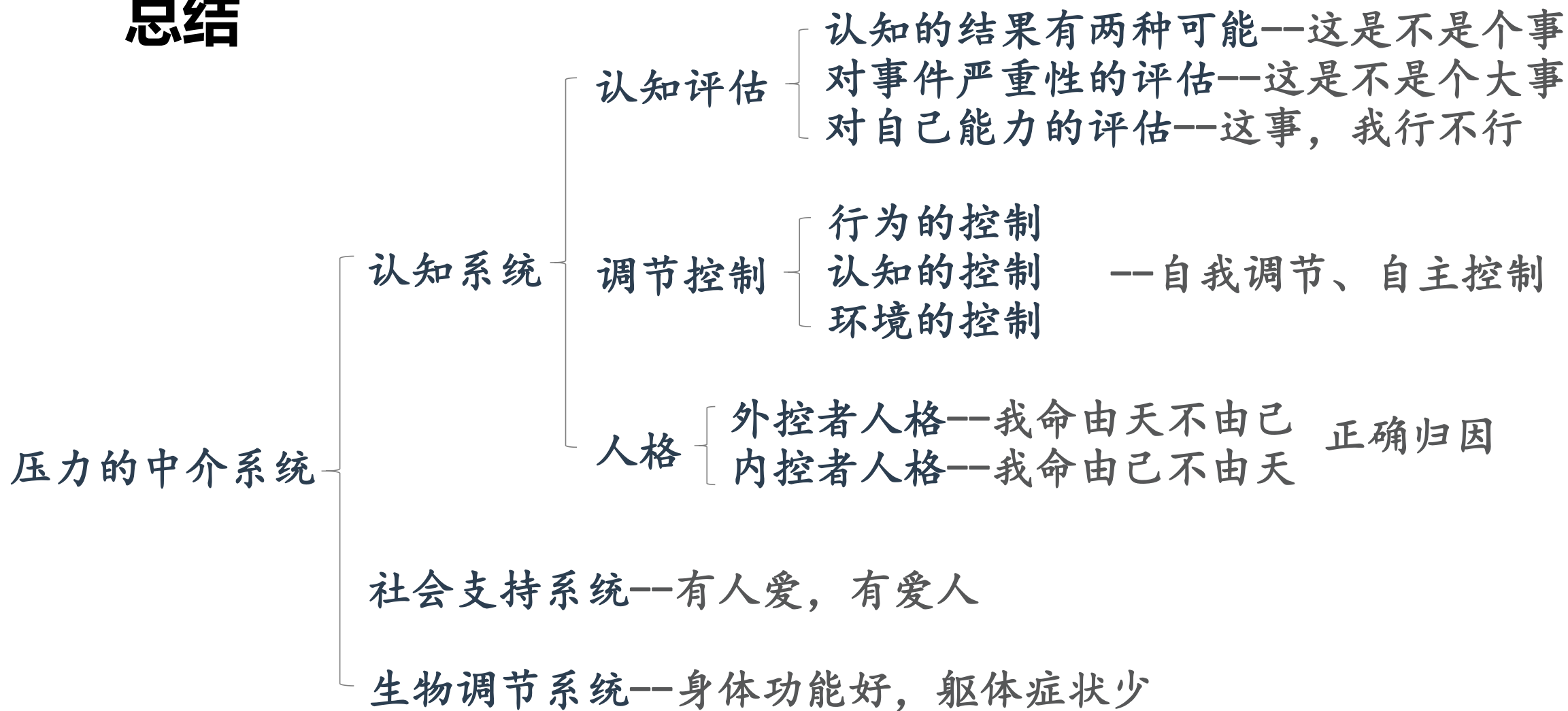
压力源：漠不关心的心态不会产生压力体验

中介系统

- 认知：外控型人格认为命运主宰人的生活。
- 社会：亲密的和可信任的关系是压力的有效缓冲器。
- 生物调节：生物调节系统作为压力的中介系统，最主要的免疫系统。

临床相：及时型的症状、滞后型的症状

总结





凡心所向，素履所往，生如逆旅，一苇以航。

THANKS



专业科普



大众心理